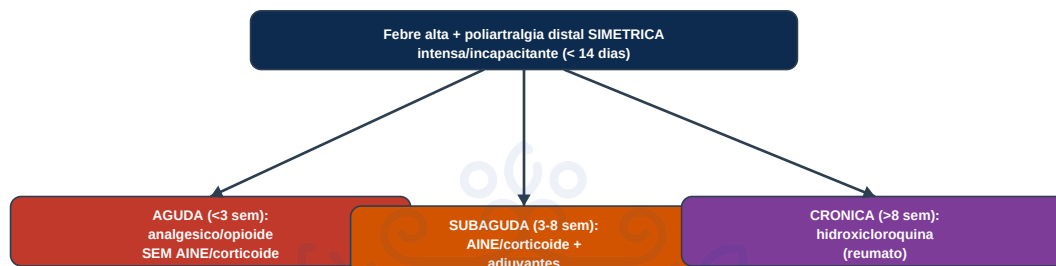


CHIKUNGUNYA — ARTRALGIA + FASES

FLUXOGRAMA — MANEJO POR FASES

CHIKUNGUNYA — FASE GUIA O ANALGÉSICO



DEFINIÇÃO E QUADRO CLÍNICO

A MARCA É A ARTRALGIA

- Alphavirus transmitido por *Aedes aegypti* e *albopictus*; 'chikungunya' = 'aquele que se dobra' (pela dor articular)
- Caso suspeito: febre $> 38,5^{\circ}\text{C}$ (< 14 dias) + artralgia/artrite intensa, sem outra causa
- POLIARTRALGIA simétrica, DISTAL, em pequenas e grandes articulações (surge no 2º-5º dia); edema periarticular
- Febre alta (~ 10 dias); exantema maculopapular precoce e NÃO pruriginoso; linfadenopatia cervical
- Laboratório: hepatite branda (TGO/TGP 100-200), trombocitopenia leve (~ 100.000), VHS/PCR elevados

DIAGNÓSTICO

CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO + LABORATÓRIO

- RT-PCR do RNA viral: até 8 dias do início dos sintomas — método de escolha na fase aguda
- Sorologia: IgM detectável a partir do 5º dia (persiste por meses); IgG indica infecção recente/passada
- Sorologias recomendadas após o 8º dia do início dos sintomas
- Diferenciar de dengue (sem artralgia incapacitante, risco de choque) e Zika (exantema pruriginoso, conjuntivite)
- Atenção à coinfeção com dengue em áreas endêmicas

MANEJO FARMACOLÓGICO POR FASE

Fase	Conduta
Aguda (até 3 sem)	Apenas analgésicos simples e opioides (se dor moderada/grave). NÃO usar AINE nem corticoide (rebote/agrava viremia)
Subaguda (3-8 sem)	AINE a partir do 14º-21º dia; Prednisona 5-20 mg/dia (mín. 6 sem); adjuvantes (amitriptilina, gabapentina)
Crônica (> 8 sem)	HIDROXICLOROQUINA 5 mg/kg (máx 400 mg/dia) por 6-12 sem; refratário: sulfassalazina/MTX + adjuvantes
Grupo de risco crônico	Mulheres, > 45 anos, substrato reumatológico prévio

REGRA DE OURO DA FASE AGUDA

NADA DE AINE/CORTICOIDE NA AGUDA

- Na fase AGUDA (< 3 semanas), NÃO administrar AINE nem corticoide — risco de efeito rebote e de agravar a viremia (e mascarar dengue concomitante, com risco de sangramento)
- Analgesia escalonada: Dipirona/Paracetamol; opioide fraco (codeína/tramadol) se dor intensa/incapacitante
- Corticoterapia (subaguda) — cuidado: DM, HAS refratária, osteoporose com fratura, Cushing, DRC em hemodiálise
- Compressas frias nas articulações (3x/dia) e repouso relativo
- Hidroxicloroquina é o pilar na fase crônica (sob acompanhamento, geralmente reumatológico)

PRESCRIÇÃO — PS E CASA

Rx SINTOMÁTICOS

PS: Dipirona 1 g EV agora; Tramadol 50 mg + SF 0,9% 100 mL EV em 20 min se dor persistente

PS: SF 0,9% 500-1000 mL EV conforme desidratação; Dexclorfeniramina 2 mg 8/8h ou Loratadina 10 mg/dia se prurido

Casa (aguda): Dipirona 1 g VO 6/6h (ou Paracetamol 750 mg 6/6h) se dor/febre

Casa: Codeína 30 mg VO 8/8h se dor intensa/incapacitante

Orientações: hidratação, repouso, compressas frias; PROIBIDO AINE e corticoide na fase aguda

CRITÉRIOS DE INTERNAÇÃO

FORMAS GRAVES E GRUPOS ESPECIAIS

- Manifestações graves: comprometimento neurológico (meningoencefalite, convulsões, rebaixamento), miocardite, IRA, insuficiência cardíaca ou qualquer disfunção orgânica aguda
- Instabilidade hemodinâmica: hipotensão, taquicardia persistente, choque, necessidade de vasoativo
- Dor incapacitante não controlada com analgesia (incluindo opioides), impedindo alimentação/hidratação/deambulação
- Gestantes com febre/suspeita (risco de transmissão vertical); NEONATOS de mães infectadas no peri-parto (risco de doença grave/encefalopatia)
- Descompensação de comorbidades; impossibilidade de manejo ambulatorial seguro

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente com chikungunya (fase ____): febre alta + poliartralgia distal simétrica incapacitante há ____ dias.
- Critério de gravidade: ____ (neurológico/miocardite/IRA/choque/dor refratária); gestante/neonato ____.
- Conduta: analgesia ____ (dipirona/opioide), hidratação ____; SEM AINE/corticoide na fase aguda.
- Solicito suporte hospitalar/UTI por gravidade ou comorbidade descompensada; CID A92.0.



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é a manifestação clínica marcante da chikungunya?

- A) Hemoconcentração e choque
- B) Poliartralgia intensa, simétrica e distal (incapacitante)
- C) Exantema pruriginoso com conjuntivite
- D) Icterícia e insuficiência renal
- E) Tosse com guincho

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Na fase AGUDA da chikungunya (< 3 semanas), qual conduta é correta?

- A) Iniciar AINE precocemente
- B) Usar analgésicos simples/opioides e NÃO usar AINE nem corticoide
- C) Corticoide em altas doses
- D) Hidroxicloroquina de imediato
- E) Antibiótico

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual é o pilar do tratamento na fase CRÔNICA da chikungunya (> 8 semanas)?

- A) Opióide contínuo
- B) Hidroxicloroquina (5 mg/kg, máx 400 mg/dia)
- C) Antiviral específico
- D) Corticoide em pulso
- E) Apenas fisioterapia

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual exame é o método de escolha no diagnóstico da chikungunya na fase aguda (até 8 dias)?

- A) Sorologia IgG
- B) RT-PCR do RNA viral
- C) Hemocultura
- D) Prova do laço
- E) Cultura de urina

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Por que se evita AINE na fase aguda da chikungunya em área endêmica?

- A) Por causar artrite
- B) Pelo risco de efeito rebote/agravo da viremia e por mascarar dengue concomitante (risco de sangramento)
- C) Por ser ineficaz para febre
- D) Porque causa exantema
- E) Não há motivo

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A marca da chikungunya é a poliartralgia intensa, simétrica e distal, frequentemente incapacitante, surgindo entre o 2º e o 5º dia.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Na fase aguda usam-se analgésicos simples e opioides; NÃO se usa AINE nem corticoide pelo risco de rebote e agravo da viremia (e mascaramento de dengue).

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Na fase crônica, o pilar é a hidroxicloroquina (5 mg/kg, máx 400 mg/dia) por 6-12 semanas, geralmente sob acompanhamento reumatológico.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O RT-PCR do RNA viral (até 8 dias) é o método de escolha na fase aguda; a sorologia IgM é útil a partir do 5º dia.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Evita-se AINE na fase aguda pelo risco de rebote/agravo da viremia e, sobretudo, por mascarar dengue concomitante (risco de sangramento) em área endêmica.

SM24
Suporte ao Plantão Médico